Estilo UERJ

Simulado 14 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Mulher de 70 anos, assintomática, faz ressonância por outro motivo, que mostra lesão cística de 22 mm na cabeça do pâncreas comunicando-se com o ducto pancreático principal, que mede 7 mm, sem nódulo mural realçante e sem componente sólido. Sem icterícia, sem pancreatite prévia e sem diabetes recente. CA 19-9 normal. O próximo passo mais adequado é:

A) Dosagem de CEA sérico

B) Ecoendoscopia

C) Duodenopancreatectomia

D) Nova ressonância em 1 ano

---

2 Mulher de 36 anos, com tireoidite de Hashimoto em uso de levotiroxina, é internada com dispneia progressiva há 10 dias, sem febre, quadro gripal ou diarreia prévios e sem uso de imunoterapia ou drogas ilícitas. Na admissão apresenta taquicardia ventricular sustentada, revertida com cardioversão, que recorre três vezes em 24 horas apesar de amiodarona, e bloqueio atrioventricular 2:1, que exige marca-passo provisório. Evolui em choque cardiogênico refratário, com noradrenalina, dobutamina e lactato de 4,8 mmol/L, e é avaliada para suporte circulatório mecânico. Troponina muito elevada. Cineangiocoronariografia: coronárias normais. Ecocardiograma: VE com diâmetro diastólico de 51 mm, FE 20%, hipocinesia difusa. Eosinófilos 220/mm³. Para definir o tratamento, o próximo exame mais adequado é:

A) Ressonância magnética cardíaca

B) PET com FDG cardíaco

C) Pesquisa viral por PCR no sangue

D) Biópsia endomiocárdica

---

3 Mulher de 54 anos tem síndrome de Sjögren primária há 10 anos, com anti-Ro reagente. Há 8 meses tem aumento indolor e persistente da parótida direita, que não regrediu com hidratação, sialogogos e antibiótico. Exames: C4 de 6 mg/dL (VR 10 a 40), fator reumatoide 280 UI/mL, crioglobulinas positivas, linfócitos 800/mm³, LDH normal, sem linfonodomegalias ao exame. A parotidectomia superficial foi laudada, só com hematoxilina-eosina, como sialadenite linfoepitelial com lesões linfoepiteliais e infiltrado linfoide denso, compatível com síndrome de Sjögren. A paciente pergunta se pode apenas manter o seguimento. O exame a solicitar agora é:

A) PET-CT de corpo inteiro

B) Biópsia de glândula salivar menor

C) Pesquisa de clonalidade B no tecido

D) Biópsia de medula óssea

---

4 Mulher de 29 anos tenta engravidar há 18 meses sem sucesso. Tem ciclos menstruais a cada 45 a 90 dias desde a menarca, acne e hirsutismo leve (escore de Ferriman de 10). IMC 31 kg/m², acantose nigricans cervical, PA 122 × 78 mmHg. Exames: TSH 1,9 mUI/L, prolactina 14 ng/mL, 17-OH-progesterona 82 ng/dL, testosterona total 68 ng/dL (referência até 60), glicemia de jejum 108 mg/dL, HbA1c 5,9%, HOMA-IR 4,8. Ultrassonografia com 24 folículos por ovário. Espermograma do marido normal e histerossalpingografia com trompas pérvias. Perdeu 4% do peso com dieta em 6 meses. Para o objetivo dela, a conduta farmacológica de primeira linha é:

A) Metformina 1.500 mg/dia isolada

B) Anticoncepcional oral combinado

C) Clomifeno associado à metformina

D) Letrozol do 3º ao 7º dia do ciclo

---

5 Mulher de 37 anos, professora de educação física, procura atendimento por cefaleia há 3 semanas, holocraniana e em peso na nuca, que surge cerca de 15 minutos depois de se levantar pela manhã e melhora em 20 minutos deitada, com zumbido, abafamento auditivo e náusea; passa parte do dia deitada. Nega trauma, febre, perda de peso e uso de anticoncepcional. Não foi submetida a punção lombar, anestesia peridural ou procedimento na coluna. Tem hipermobilidade articular desde a infância. Exame neurológico e fundo de olho normais; PA 118 × 74 mmHg. TC de crânio sem contraste, feita na emergência, normal. O próximo exame mais adequado é:

A) RM de encéfalo com gadolínio

B) Angiorressonância venosa cerebral

C) Punção lombar com manometria

D) Angiotomografia de vasos cervicais

---

6 Mulher de 58 anos com artrite reumatoide soropositiva há 2 anos, sem doença pulmonar na TC de rastreio feita ao diagnóstico, iniciou metotrexato há 4 meses (dose atual 20 mg/semana, com ácido fólico). Há 10 dias tem febre de 38,3 °C, tosse seca e dispneia progressiva. FR 28 irpm, SpO2 88% em ar ambiente, estertores finos bilaterais. Leucócitos 9.800/mm³ com 9% de eosinófilos; PCR 6 mg/dL. TC de tórax: vidro fosco difuso bilateral, sem faveolamento nem bronquiectasias de tração. Antígeno urinário, painel viral, beta-D-glucana e culturas negativos; ecocardiograma normal. O diagnóstico e a conduta mais adequados são, respectivamente:

A) DPI da artrite reumatoide / nintedanibe

B) Pneumonite por metotrexato / suspender e corticoide

C) Pneumocistose / sulfametoxazol-trimetoprima

D) DPI da artrite reumatoide / ciclofosfamida

---

7 Homem de 78 anos, com hiperplasia prostática e retenção urinária, usa sonda vesical de demora há 4 semanas enquanto aguarda a cirurgia. Há 1 dia tem febre de 38,6 °C e calafrios, sem tosse, sem diarreia, sem flebite e sem lesões de pele; a próstata não está dolorosa ao toque. PA 124 × 72 mmHg, FC 100 bpm, lucidez preservada. A UPA enviou urina colhida da bolsa coletora: mais de 100.000 UFC/mL de Escherichia coli, Enterococcus faecalis e Proteus mirabilis. Hemoculturas foram colhidas há 30 minutos. A sonda ainda é necessária, e o antibiótico não foi iniciado. O próximo exame mais adequado, antes do antibiótico, é:

A) Urocultura da nova sonda, após a troca

B) Ultrassonografia de rins e vias urinárias

C) Repetir a urocultura da bolsa coletora

D) Urocultura por punção da sonda atual

---

8 Homem de 46 anos, transplantado renal há cinco meses, em uso de tacrolimo, micofenolato, prednisona 5 mg/dia e sulfametoxazol-trimetoprima 400/80 mg/dia como profilaxia. Não é diabético. Há duas semanas outro serviço iniciou diltiazem por taquicardia sinusal. Agora: PA 158/96 mmHg (era 128/80 mmHg), sem edema, peso estável, tremor fino de mãos. Exames: potássio 6,1 mEq/L, cloro 112 mEq/L, bicarbonato 18 mEq/L, magnésio 1,2 mg/dL, creatinina 1,4 mg/dL (basal 1,3), glicemia 98 mg/dL, renina suprimida, aldosterona baixa, cortisol matinal normal, nível de vale do tacrolimo de 17 ng/mL (alvo de 6 a 9). O mecanismo que melhor explica a hipercalemia com hipertensão é:

A) Rejeição aguda do enxerto

B) Bloqueio do ENaC pela trimetoprima

C) Insuficiência adrenal relativa

D) Ativação do NCC no túbulo distal

---

9 Gestante de 29 anos, G1, com 38 semanas, tem púrpura trombocitopênica imunológica diagnosticada há 3 anos, com plaquetas basais entre 60.000 e 80.000/mm³, sem tratamento desde então. PA 114 x 72 mmHg, sem proteinúria, LDH, AST e creatinina normais, esfregaço com plaquetas grandes e sem esquizócitos. Está assintomática, sem petéquias, equimoses ou sangramento mucoso. Plaquetas hoje de 46.000/mm³ (52.000 há 2 semanas). Feto cefálico, sem indicação obstétrica de cesariana; a indução do parto está marcada para daqui a 4 dias, e ela deseja analgesia peridural. O anestesista avisa que só faz o bloqueio neuraxial com plaquetas a partir de 70.000/mm³. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Observação até o parto

B) Cesariana eletiva programada

C) Plaquetas antes da peridural

D) Imunoglobulina intravenosa

---

10 Homem de 63 anos, com adenocarcinoma gástrico metastático para fígado e peritônio, tumor primário ulcerado de 6 cm no corpo gástrico ainda não ressecado, em quimioterapia paliativa com FOLFOX, apresenta trombose venosa profunda femoropoplítea esquerda confirmada por Doppler. Teve melena há 2 meses, tratada endoscopicamente, sem sangramento desde então. Hb 10,8 g/dL, plaquetas 210.000/mm³, clearance de creatinina 78 mL/min, peso 68 kg. Sem outras interações medicamentosas relevantes. O residente lembra que os anticoagulantes orais diretos substituíram a heparina no tromboembolismo associado ao câncer. O anticoagulante mais adequado para este paciente é:

A) Enoxaparina em dose plena

B) Rivaroxabana

C) Edoxabana após 5 dias de heparina

D) Varfarina com INR entre 2 e 3

---

11 Mulher de 32 anos, professora de educação infantil, tem há 10 dias dor e edema simétricos em metacarpofalangeanas, interfalangeanas proximais e punhos, com rigidez matinal de 1 hora. Duas semanas antes teve febre baixa e coriza, e vários alunos tiveram as bochechas muito vermelhas. Exame físico: sinovite em oito pequenas articulações das mãos e nos punhos, exantema reticulado tênue nas coxas. Exames: Hb 12,4 g/dL, leucócitos 4.200/mm³, plaquetas 160.000/mm³, VHS 34 mm/h, fator reumatoide 32 UI/mL (VR até 14), anti-CCP não reagente, FAN 1:160 pontilhado fino, IgM anti-parvovírus B19 reagente. Radiografias de mãos sem erosões. A conduta mais adequada é:

A) Hidroxicloroquina 400 mg/dia

B) Imunoglobulina humana venosa

C) Anti-inflamatório e reavaliação clínica

D) Metotrexato 15 mg/semana

---

12 Homem de 76 anos, diabético e hipertenso, com estenose aórtica, refere angina e dispneia aos médios esforços há 4 meses. Independente, caminha 2 km por dia, teste de fragilidade normal, sem pneumopatia, função renal normal; escore STS de mortalidade de 2,6%. Ecocardiograma: valva aórtica trivalvular calcificada, área de 0,7 cm², gradiente médio de 52 mmHg, FE 58%. Angiotomografia: aorta sem calcificação em porcelana e acessos femorais adequados. Cineangiocoronariografia: lesão de 70% no tronco da coronária esquerda distal, estenoses de 80% na descendente anterior proximal e na circunflexa e de 90% na coronária direita média, com escore SYNTAX de 34. Na reunião do heart team, o residente argumenta que 'acima de 75 anos a escolha é TAVI'. A conduta mais adequada é:

A) TAVI transfemoral sem tratar as coronárias

B) Troca valvar cirúrgica com revascularização miocárdica

C) Valvoplastia aórtica por balão como ponte

D) TAVI transfemoral com angioplastia multiarterial

---

13 Homem de 46 anos, analista de sistemas, sofreu fratura vertebral de L1 ao levantar uma caixa de 12 kg. Não fuma, não bebe e não usa corticoide, anticonvulsivante nem inibidor de bomba de prótons. Refere apenas distensão abdominal ocasional, que atribui a intolerância à lactose; peso estável, IMC 22 kg/m². Densitometria: T-escore de -2,9 na coluna lombar e de -2,2 no colo femoral. Exames: hemoglobina 12,8 g/dL, VCM 77 fL, ferritina 11 ng/mL, creatinina 0,9 mg/dL, cálcio 8,6 mg/dL (albumina 4,0 g/dL), fósforo 3,0 mg/dL, fosfatase alcalina normal, PTH 84 pg/mL (referência 15 a 65), 25-hidroxivitamina D 17 ng/mL, calciúria de 24 horas de 52 mg, testosterona total matinal de 520 ng/dL, TSH e eletroforese de proteínas normais. O ortopedista prescreveu alendronato e colecalciferol. Antes de iniciar o tratamento, o exame que falta é:

A) Antitransglutaminase IgA com IgA total

B) Cortisol salivar ao final da noite

C) Biópsia óssea com dupla marcação

D) Cintilografia óssea de corpo inteiro

---

14 Homem de 69 anos, com angioplastia coronária e stent farmacológico há 8 meses, em uso de AAS 100 mg e clopidogrel 75 mg, é admitido 2 horas após o início de hemiparesia esquerda e disartria. PA 186/100 mmHg, Glasgow 15. TC: hematoma putaminal direito de 18 mL, sem extensão ventricular e sem desvio de linha média; a neurocirurgia não indica intervenção. Plaquetas 245.000/mm³, RNI 1,0, TTPa normal, fibrinogênio 310 mg/dL. Iniciada nicardipina com meta de PAS de 140 mmHg. Quanto à antiagregação, além de suspender AAS e clopidogrel, a conduta mais adequada é:

A) Plasma fresco congelado 15 mL/kg

B) Transfusão de uma aférese de plaquetas

C) Complexo protrombínico de 4 fatores

D) Nenhuma medida hemostática adicional

---

15 Homem de 57 anos com psoríase em placas há 20 anos, agora com 30% da superfície corporal acometida e prurido que atrapalha o sono, sem resposta a corticoide tópico e calcipotriol. Usa sacubitril-valsartana, bisoprolol, espironolactona e dapagliflozina, e tem dispneia aos pequenos esforços há 1 ano. Não bebe álcool. Exames: creatinina 1,8 mg/dL (TFGe 42 mL/min/1,73 m²), AST 58 U/L, ALT 64 U/L, plaquetas 140.000/mm³, FIB-4 de 2,95; elastografia hepática de 13 kPa. IGRA negativo; sorologias para hepatites B e C negativas. O tratamento sistêmico mais adequado é:

A) Risanquizumabe subcutâneo

B) Infliximabe intravenoso

C) Ciclosporina oral

D) Metotrexato semanal com ácido fólico

---

16 Homem de 25 anos, gari, desentupiu bueiros durante uma enchente há 3 semanas. Há 12 dias teve febre alta, cefaleia e mialgia intensa nas panturrilhas, com melhora espontânea no 7º dia. Há 2 dias voltou a ter febre, cefaleia intensa e fotofobia; está no 12º dia desde o início dos sintomas. Exame: T 38,2 °C, rigidez de nuca leve, sufusão conjuntival, sem icterícia, sem déficit focal. Líquor: 180 células/mm³ (85% linfócitos), proteína 72 mg/dL, glicose 60 mg/dL (glicemia 98 mg/dL), bacterioscopia negativa. Creatinina 1,1 mg/dL, plaquetas 160.000/mm³, CK 600 U/L. Para confirmar o diagnóstico etiológico, o exame mais adequado agora é:

A) Sorologia (ELISA IgM) para leptospirose

B) PCR para Leptospira no sangue

C) Hemocultura em meio para Leptospira

D) Microscopia de campo escuro no sangue

---

17 Homem de 66 anos, com diagnóstico de psoríase há 4 anos, tratado com corticoide tópico e, há 6 meses, com metotrexato, sem melhora, evolui com eritrodermia em 90% da superfície corporal, descamação fina, prurido intenso, ceratodermia palmoplantar fissurada e queda de cabelos. Linfonodos axilares e inguinais de 2 cm, móveis. Hemograma: leucócitos 14.200/mm³, linfócitos 7.900/mm³, eosinófilos 900/mm³. O esfregaço mostra linfócitos de núcleo cerebriforme. Citometria de fluxo do sangue: linfócitos T CD4+ com perda de CD7 e CD26, em contagem de 2.400/mm³, relação CD4/CD8 de 18. Sorologias para HIV e HTLV-1 negativas, cálcio sérico normal. O diagnóstico mais provável é:

A) Psoríase eritrodérmica

B) Síndrome de Sézary

C) Leucemia/linfoma de células T do adulto

D) Dermatite atópica eritrodérmica

---

18 Homem de 36 anos, com polipose adenomatosa familiar (mutação germinativa do APC), foi submetido aos 21 anos a proctocolectomia total com bolsa ileal. Faz endoscopia anual da bolsa, a última há 3 meses, sem adenomas. Assintomático. TC de abdome há 2 anos sem tumor desmoide. Nunca fez endoscopia alta, porque lhe disseram que o risco era do intestino grosso, já retirado. Exame físico normal. O exame mais importante a incluir agora no seguimento é:

A) Cápsula endoscópica do delgado

B) TC de abdome anual para desmoide

C) Nenhum exame além da endoscopia da bolsa

D) Endoscopia com visão frontal e lateral

---

19 Mulher de 36 anos, com três episódios de cólica nefrética em cinco anos; a tomografia mostra nefrocalcinose medular bilateral, e o último cálculo analisado era de fosfato de cálcio (apatita). Sem diarreia, sem uso de acetazolamida ou topiramato, sem boca ou olhos secos. Exames: sódio 140 mEq/L, potássio 3,9 mEq/L, cloro 106 mEq/L, bicarbonato 24 mEq/L, cálcio 9,4 mg/dL, PTH 41 pg/mL, 25-hidroxivitamina D 34 ng/mL. Urina de 24 horas: volume 2,1 L, cálcio 210 mg, citrato 110 mg (normal acima de 320 mg). pH urinário de 6,7 na primeira urina da manhã, em jejum, repetido em três dias. O exame mais adequado para definir a causa é:

A) Teste de acidificação urinária

B) Cintilografia de paratireoides

C) Ânion gap urinário em amostra

D) Oxalato urinário de 24 horas

---

20 Mulher de 34 anos tem lúpus com síndrome antifosfolípide (trombose venosa profunda prévia, tripla positividade) e suspendeu a varfarina por conta própria há 3 semanas. Há 4 dias, após infecção urinária, evolui com dor abdominal, confusão mental, dispneia e oligúria. Exame físico: PA 168 × 100 mmHg, FC 118 bpm, SpO2 90% em ar ambiente, livedo reticular em tronco e coxas. Exames: Hb 9,8 g/dL com 2 esquizócitos por campo, plaquetas 42.000/mm³, creatinina 3,4 mg/dL, troponina elevada, TC de abdome com infartos esplênico e renal, ressonância de crânio com múltiplos infartos corticais pequenos. Hemoculturas negativas. A anticoagulação e o tratamento associado mais adequados são, respectivamente:

A) Heparina não fracionada plena / glicocorticoide e plasmaférese

B) Suspender anticoagulação / transfusão de plaquetas

C) Heparina profilática / rituximabe isolado

D) Varfarina / AAS e hidroxicloroquina

---

21 Homem de 63 anos, sem valvopatia prévia, perdeu 10 kg em 3 meses, com dor epigástrica que irradia para o dorso. Há 5 semanas teve trombose venosa femoral e, desde então, cordões dolorosos que surgem e somem nos braços. Há 2 semanas usou amoxicilina por 5 dias para sinusite. É internado por afasia súbita e, dois dias depois, fraqueza na mão esquerda; a ressonância mostra infartos agudos em territórios dos dois hemisférios. Permaneceu sem febre durante toda a internação; sem sopro novo; leucócitos 8.900/mm³, PCR 1,9 mg/dL. Três pares de hemoculturas negativos; sorologias para Coxiella burnetii e Bartonella negativas. Ecocardiograma transesofágico: vegetações sésseis de 3 a 5 mm na face atrial dos dois folhetos mitrais, sem regurgitação significativa, perfuração ou abscesso. Tomografia: massa de 3,5 cm no corpo do pâncreas. D-dímero muito elevado. A etiologia mais provável das vegetações é:

A) Endocardite por Coxiella burnetii

B) Fibroelastoma papilífero mitral

C) Endocardite trombótica não bacteriana

D) Endocardite infecciosa decapitada por antibiótico

---

22 Mulher de 83 anos, independente, com hipertensão controlada e osteoartrite, refere cansaço e constipação há anos, sem piora recente. Não usa amiodarona, lítio nem suplementos com iodo. Exame: PA 134 × 76 mmHg, FC 68 bpm, tireoide não palpável, sem edema. Exames: TSH 8,6 mUI/L e, após 10 semanas, 9,1 mUI/L; T4 livre de 1,0 ng/dL (referência 0,9 a 1,8) nas duas dosagens; anti-TPO 140 UI/mL (referência até 35); LDL 128 mg/dL; hemoglobina 12,6 g/dL. Sem insuficiência cardíaca. A filha pede o hormônio porque a mãe está com a tireoide fraca. A conduta mais adequada é:

A) Levotiroxina 1,6 µg/kg/dia

B) Levotiroxina 25 µg/dia

C) Levotiroxina se o LDL não cair com dieta

D) Não tratar e repetir o TSH em 6 a 12 meses

---

23 Homem de 38 anos, previamente hígido, operou hérnia inguinal há 3 semanas. Cinco dias depois acordou com dor lancinante no ombro e na região escapular direitos, que não cedia com anti-inflamatório e o impedia de dormir; a ortopedia registrou 'tendinite do manguito rotador' e indicou fisioterapia. Há 1 semana a dor quase desapareceu, mas surgiu dificuldade para elevar o braço e pentear o cabelo. Exame: escápula alada à direita ao empurrar a parede, atrofia do deltoide e do supraespinal, força grau 3 na abdução e na rotação externa do ombro, pequena área de hipoestesia na face lateral do braço; sem dor cervical, Spurling negativo, bíceps e tricipital simétricos. RM do ombro: edema muscular difuso no supraespinal e no infraespinal, tendões íntegros. O diagnóstico mais provável é:

A) Radiculopatia C5-C6 por hérnia discal

B) Ruptura do manguito rotador

C) Neurite braquial idiopática

D) Síndrome do desfiladeiro torácico

---

24 Mulher de 34 anos, com retocolite ulcerativa extensa, está internada há 5 dias por colite aguda grave, em hidrocortisona intravenosa e, por falta de resposta no 3º dia, recebeu infliximabe 5 mg/kg. Pesquisa de toxina de Clostridioides difficile negativa e biópsias retais sem citomegalovírus. Hoje tem distensão abdominal, FC 124 bpm, temperatura 38,9 °C, PA 96×60 mmHg, leucócitos 19.000/mm³ e albumina 2,4 g/dL. Os opioides e antidiarreicos foram suspensos. Radiografia de abdome: cólon transverso com 8 cm, sem pneumoperitônio. O diagnóstico e a conduta são, respectivamente:

A) Megacólon tóxico / ciclosporina de resgate

B) Colite grave sem megacólon / nova dose de infliximabe

C) Megacólon tóxico / colectomia subtotal

D) Megacólon tóxico / colonoscopia descompressiva

---

25 Homem de 66 anos com DPOC (VEF1 48% do previsto) e bronquiectasias cilíndricas nos lobos inferiores, em tiotrópio-olodaterol, teve duas exacerbações no último ano. As culturas de escarro trimestrais dos últimos 3 anos cresceram apenas Haemophilus influenzae. Em consulta de rotina, sem febre, sem piora da tosse e com escarro mucoide habitual, a cultura cresce Pseudomonas aeruginosa sensível a ciprofloxacino pela primeira vez. A conduta mais adequada é:

A) Erradicação com ciprofloxacino oral

B) Azitromicina contínua

C) Repetir a cultura em 3 meses

D) Internar para antibiótico venoso

---

26 Homem de 24 anos, estudante, do Rio de Janeiro, nadou numa lagoa do interior de Minas Gerais durante o Carnaval, há 5 semanas. Lembra de coceira nas pernas no dia seguinte. Há 2 semanas tem febre de 38,5 °C ao fim da tarde, tosse seca, urticária, dor abdominal difusa e diarreia sem sangue. Exame: T 38,3 °C, hepatomegalia dolorosa a 3 cm do rebordo, sem esplenomegalia, sem linfonodomegalia. Hemograma: leucócitos 14.200/mm³ com 34% de eosinófilos; radiografia de tórax com infiltrado micronodular discreto. Três amostras de parasitológico de fezes pelo método de Kato-Katz, colhidas nesta semana, foram negativas. Hemoculturas negativas. O diagnóstico mais provável é:

A) Estrongiloidíase

B) Síndrome de Löffler por Ascaris

C) Esquistossomose aguda

D) Toxocaríase visceral

---

27 Homem de 76 anos, com doença renal crônica estágio 3b (TFG estimada de 38 mL/min/1,73 m², estável há 2 anos) por nefroesclerose hipertensiva, é encaminhado ao hematologista para iniciar alfaepoetina. A Hb caiu de 12,1 para 9,2 g/dL em 8 meses. VCM 90 fL, reticulócitos 0,7%, ferritina 310 ng/mL, saturação de transferrina 28%, B12 e folato normais. Refere lombalgia há 3 meses, atribuída a artrose. Exames: VHS 96 mm/h, proteínas totais 8,9 g/dL com albumina 3,3 g/dL, cálcio 10,4 mg/dL, creatinina 1,7 mg/dL. O próximo exame mais adequado é:

A) Pesquisa de sangue oculto nas fezes

B) Mielograma com biópsia de medula

C) Eletroforese e imunofixação com cadeias leves livres

D) Dosagem de eritropoetina sérica

---

28 Mulher de 27 anos é trazida 10 horas depois de ingerir, intencionalmente, cerca de 60 comprimidos de 500 mg de ácido acetilsalicílico. Refere zumbido e vômitos; está agitada e desorientada no tempo. Peso 60 kg. FR 32 irpm, FC 118 bpm, PA 112/70 mmHg, SpO2 de 97% em ar ambiente, Tax 37,9 °C. Gasometria arterial: pH 7,47, pCO2 21 mmHg, bicarbonato 15 mEq/L. Sódio 141 mEq/L, cloro 102 mEq/L, potássio 3,4 mEq/L, glicemia 96 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL. Salicilemia de 78 mg/dL, repetida em 2 horas: 84 mg/dL. Radiografia de tórax normal. O distúrbio ácido-base e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) Alcalose respiratória isolada / carvão ativado

B) Alcalose respiratória e acidose metabólica / alcalinização isolada

C) Alcalose respiratória e acidose metabólica / hemodiálise

D) Acidose metabólica isolada / bicarbonato intravenoso

---

29 Homem de 71 anos, transplantado renal há 6 anos, em uso de tacrolimo, micofenolato e prednisona 5 mg/dia, teve pielonefrite há 12 dias. A urocultura mostrou Escherichia coli resistente a sulfametoxazol-trimetoprima e a amoxicilina-clavulanato, e ele recebeu alta com um antibiótico oral de dose única diária, alta biodisponibilidade e ação também contra Pseudomonas, por 10 dias. Há 3 dias tem dor nos dois calcanhares ao caminhar, sem febre e sem trauma. Exame físico: espessamento doloroso dos tendões calcâneos cerca de 3 cm acima da inserção, bilateralmente, teste de Thompson normal, sem artrite em outras articulações, sem lesões de pele, sem uretrite. Ácido úrico 8,1 mg/dL. A causa mais provável é:

A) Tendinopatia por fluoroquinolona

B) Gota com acometimento tendíneo

C) Entesite de artrite reativa

D) Tendinopatia pelo tacrolimo

---

30 Em transplantado renal em uso de tacrolimo, micofenolato e prednisona, com múltiplos carcinomas espinocelulares cutâneos ressecados no último ano, a modificação da imunossupressão com maior redução comprovada de novos carcinomas é:

A) Trocar tacrolimo por ciclosporina

B) Converter para inibidor de mTOR

C) Trocar micofenolato por azatioprina

D) Suspender a prednisona

---

31 Homem de 31 anos, natural do interior da Bahia, onde morou em casa de taipa até os 18 anos, procura atendimento por cansaço aos médios esforços há 8 meses. Desde a adolescência tem cãibras e dor muscular após exercício e, há alguns anos, dificuldade para subir escadas e levantar do chão, mas caminha sem apoio. Um tio materno usou cadeira de rodas desde os 20 anos e morreu aos 40 'do coração'; o pai e as irmãs são saudáveis. Ao exame: panturrilhas volumosas e de consistência firme, fraqueza de cintura pélvica grau 4, apoio nas coxas para se levantar. PA 110×70 mmHg, FC 86 bpm, B3 discreta. CK 5.600 U/L (referência até 190). Ecocardiograma: FE 40%, hipocinesia da parede inferolateral basal. A sorologia para doença de Chagas foi colhida e o resultado está pendente. O achado eletrocardiográfico mais esperado é:

A) Baixa voltagem com padrão de pseudoinfarto

B) R alta em V1 com Q profundas em DI, aVL e V6

C) Bloqueio de ramo direito com divisional anterossuperior

D) Onda épsilon com T negativa de V1 a V3

---

32 Homem de 45 anos, pedreiro, recebe alta após 3 semanas de UTI por tétano acidental generalizado, que se seguiu a um ferimento com prego no pé. Foi tratado com imunoglobulina humana antitetânica, metronidazol, desbridamento, benzodiazepínico e suporte ventilatório, com recuperação completa. Não tem registro de vacinação em nenhum momento da vida, e nenhuma vacina foi aplicada durante a internação. Quanto à vacinação antitetânica na alta, a conduta correta é:

A) Dose única de reforço de dT

B) Esquema completo de três doses de dT

C) Nenhuma, pois a doença confere imunidade

D) Dosar anticorpos antitetânicos antes de vacinar

---

33 Mulher de 44 anos, tireoidectomizada há 6 anos por bócio multinodular, mantinha TSH entre 1,0 e 2,5 mUI/L com levotiroxina 125 µg em jejum, 40 minutos antes do café. Há 4 meses teve diagnóstico de anemia por menorragia (hemoglobina 9,6 g/dL, ferritina 6 ng/mL), e o ginecologista prescreveu um comprimido para o sangue, que ela toma junto com a levotiroxina para não esquecer. Hoje refere fadiga e intolerância ao frio: TSH 14,2 mUI/L, T4 livre 0,7 ng/dL; hemoglobina 11,8 g/dL, ferritina 28 ng/mL. Nega troca de marca do comprimido de levotiroxina, gestação, uso de inibidor de bomba de prótons e diarreia. Peso estável. A causa mais provável da elevação do TSH é:

A) Perda de adesão ao tratamento

B) Menor absorção da levotiroxina pelo ferro

C) Doença celíaca com má absorção

D) Aumento da TBG pelo estrogênio

---

34 Mulher de 34 anos apresentou, há 9 dias, dormência ascendente nas pernas seguida de paraparesia e retenção urinária, com nível sensitivo em T6 instalado em 48 horas. RM: lesão medular em T5-T6, de dois segmentos, com realce; RM de encéfalo normal. Líquor: 18 células/mm³ (linfócitos), proteína 62 mg/dL, sem bandas oligoclonais. Anti-aquaporina-4 e anti-MOG negativos por ensaio celular; sorologias para HIV, sífilis, HTLV-1 e herpesvírus negativas, B12 e cobre normais. Recebeu metilprednisolona 1 g/dia por 5 dias, terminada há 2 dias, e permanece com força grau 1 nos membros inferiores e sem controle esfincteriano. A conduta mais adequada agora é:

A) Rituximabe intravenoso

B) Plasmaférese terapêutica

C) Ciclofosfamida intravenosa

D) Reabilitação, reavaliar em 4 semanas

---

35 Homem de 60 anos, receptor de transplante autólogo de células-tronco há 2 meses, por isso com indicação de hemocomponentes irradiados, é admitido com hemorragia por varizes esofágicas. Recebe, em 40 minutos, por cateter venoso central, 6 unidades de concentrado de hemácias. As unidades foram coletadas há 20 dias e irradiadas há 13 dias, dentro do prazo de validade. Função renal normal na admissão, sem uso de diuréticos poupadores de potássio. A alteração eletrolítica mais provável, consequência direta da idade e do processamento dessas unidades, é:

A) Hiperpotassemia

B) Hipomagnesemia

C) Alcalose metabólica

D) Hipocalcemia ionizada

---

36 Homem de 45 anos com sarcoidose pulmonar estádio III, confirmada por biópsia, é tratado há 14 meses com prednisona por queda da CVF de 78% para 64% e dispneia. Com 30 mg/dia a CVF voltou a 76%, mas em três tentativas de reduzir abaixo de 15 mg/dia houve nova queda funcional e piora dos sintomas. Agora tem glicemia de jejum de 142 mg/dL, o IMC subiu de 26 para 31 kg/m² e a densitometria mostra osteopenia. RM cardíaca e exame neurológico normais. A conduta mais adequada é:

A) Prednisona 40 mg/dia prolongada

B) Infliximabe, mantendo a prednisona

C) Suspender a prednisona e observar

D) Associar metotrexato e reduzir a prednisona

---

37 Homem de 45 anos, que há 5 meses iniciou treinos intensos de musculação, tem há 3 meses endurecimento progressivo da pele dos antebraços e das pernas, com dificuldade para fechar as mãos e estender os cotovelos. Nega fenômeno de Raynaud, pirose e disfagia. Exame físico: pele de antebraços e pernas endurecida, com aspecto de casca de laranja e depressões lineares ao longo das veias quando eleva os braços; dedos, mãos e face poupados; sem telangiectasias e sem úlceras digitais. Exames: leucócitos 11.200/mm³ com 18% de eosinófilos, VHS 48 mm/h, gamaglobulina policlonal aumentada, FAN não reagente. Um colega firmou diagnóstico de esclerose sistêmica difusa e quer iniciar micofenolato. O exame mais adequado para confirmar o diagnóstico é:

A) Capilaroscopia periungueal

B) Biópsia de pele por punch

C) Anti-Scl-70 e anti-RNA polimerase III

D) Biópsia em bloco da pele até a fáscia

---

38 Mulher de 56 anos, com hepatite C crônica genótipo 1 nunca tratada (HCV-RNA de 1,8 milhão de UI/mL, elastografia de 7,8 kPa), apresenta púrpura palpável intermitente nas pernas e artralgias. PA 142/88 mmHg. Exames: creatinina 1,1 mg/dL, estável em três dosagens nos últimos seis meses, proteinúria de 1,4 g/24 h, sedimento com 12 hemácias dismórficas por campo, albumina 3,7 g/dL, C4 muito baixo, C3 discretamente baixo, fator reumatoide positivo, crioglobulinas mistas tipo II positivas. Biópsia renal: glomerulonefrite membranoproliferativa com trombos intraluminais, sem crescentes. Sem neuropatia, sem úlceras cutâneas, sem dor abdominal. Além do IECA, a conduta inicial mais adequada é:

A) Rituximabe associado ao antiviral

B) Antiviral de ação direta, isoladamente

C) Plasmaférese com pulsoterapia

D) Ciclofosfamida com glicocorticoide

---

39 Homem de 49 anos, etilista pesado até 2 anos atrás, com pancreatite crônica calcificante e diabetes, é internado por hematêmese. Endoscopia: varizes gástricas isoladas no fundo, com estigma de sangramento, sem varizes esofágicas. Exame: baço palpável a 4 cm do rebordo, sem ascite, sem aranhas vasculares ou eritema palmar. Plaquetas 98.000/mm³, albumina 4,0 g/dL, bilirrubina 0,8 mg/dL, INR 1,1. Elastografia hepática de 5,8 kPa. Doppler: veia porta pérvia e de calibre normal. A causa mais provável das varizes é:

A) Síndrome de Budd-Chiari

B) Esquistossomose hepatoesplênica

C) Trombose da veia esplênica

D) Cirrose alcoólica compensada

---

40 Mulher de 68 anos, diabética, fez artroplastia total do quadril direito há 5 semanas, com boa evolução inicial. Há 6 dias tem febre de 38,4 °C, dor progressiva no quadril e hiperemia com flutuação na cicatriz, sem fístula. PA 130 × 78 mmHg, FC 96 bpm. PCR 18 mg/dL. Radiografia: componentes bem posicionados, sem radiolucência ou sinais de soltura. Artrocentese: líquido turvo, 46.000 leucócitos/mm³ com 92% de polimorfonucleares; a cultura cresceu Staphylococcus aureus sensível à oxacilina e à rifampicina. Hemoculturas negativas. A conduta mais adequada é:

A) Revisão em dois tempos com espaçador

B) Antibiótico supressivo sem cirurgia

C) Desbridamento e retenção do implante

D) Revisão em um tempo com nova prótese

---

41 Mulher de 74 anos, com hipertensão e diabetes controlados, ativa e independente (ECOG 1), FE de 60% e creatinina de 1,0 mg/dL, recebe diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda B: leucócitos 38.000/mm³ com 70% de blastos, imunofenotipagem CD19+, CD10+, TdT+, citogenética com t(9;22) e transcrito BCR-ABL1 p190. Líquor sem blastos. A família lembra que um tio morreu de 'leucemia de idoso' durante quimioterapia e teme o tratamento. O esquema de indução mais adequado é:

A) Hiper-CVAD com rituximabe

B) Inibidor de tirosina-quinase com corticoide

C) Cuidados paliativos exclusivos

D) Transplante alogênico imediato

---

42 Homem de 47 anos, sem fatores de risco cardiovascular, recebe a primeira dose de amoxicilina-clavulanato por via oral numa unidade de pronto atendimento. Cerca de 15 minutos depois surgem urticária generalizada, edema labial, sibilos e dor retroesternal em aperto. PA 84×50 mmHg, FC 112 bpm. O ECG, registrado antes de qualquer medicação, mostra supradesnivelamento do ST de 2 mm em DII, DIII e aVF, com infradesnivelamento recíproco em aVL. Recebe adrenalina intramuscular, expansão volêmica, anti-histamínico e corticoide; dor, hipotensão e alterações do ST desaparecem em 25 minutos. A cineangiocoronariografia urgente mostra coronárias sem lesões ou trombo. Troponina com pico discreto; triptase sérica colhida em 1 hora elevada. Ecocardiograma no dia seguinte: contratilidade segmentar normal, FE 62%. A causa mais provável do supradesnivelamento do ST é:

A) Vasoespasmo coronariano por mediadores dos mastócitos

B) Cardiomiopatia de estresse induzida pela adrenalina

C) Ruptura de placa aterosclerótica com trombose

D) Embolia coronária paradoxal

---

43 Homem de 50 anos é encaminhado com diagnóstico de hemocromatose genética para iniciar flebotomias. Tem obesidade (IMC 33 kg/m²), diabetes tipo 2, hipertensão e esteatose à ultrassonografia; não bebe álcool. Exames: ferritina 980 ng/mL, ferro sérico 92 µg/dL, saturação de transferrina 31%, hemoglobina 15,1 g/dL, ALT 58 U/L, PCR 4 mg/L, plaquetas 230.000/mm³. Pesquisa do HFE: heterozigose composta C282Y/H63D. O irmão de 47 anos, com o mesmo genótipo, tem ferritina normal. Sem hepatoesplenomegalia nem hiperpigmentação. O diagnóstico mais provável para a hiperferritinemia é:

A) Doença hepática alcoólica oculta

B) Hemocromatose por mutação na ferroportina

C) Hiperferritinemia dismetabólica

D) Hemocromatose HFE por heterozigose composta

---

44 Homem de 63 anos, com esclerose lateral amiotrófica de início bulbar diagnosticada há 10 meses, em uso de riluzol, vem à consulta com engasgos frequentes com líquidos, refeições que duram mais de uma hora e perda de 9% do peso em 3 meses (IMC atual de 20 kg/m²). Dorme sentado em duas almofadas por falta de ar ao deitar e acorda com cefaleia. Capacidade vital forçada de 58% do previsto sentado; pressão inspiratória máxima de -48 cmH2O; gasometria diurna com PaCO2 de 43 mmHg. Deseja todas as medidas que prolonguem a vida, exceto traqueostomia. Quanto à gastrostomia e à ventilação não invasiva, a conduta é, respectivamente:

A) Aguardar CVF abaixo de 50% / aguardar CVF abaixo de 50%

B) Indicar agora / aguardar CVF abaixo de 50%

C) Aguardar CVF abaixo de 50% / indicar agora

D) Indicar agora / indicar agora

---

45 Mulher de 56 anos procura o ambulatório por dispneia aos médios esforços que piora há 8 meses. Há 1 ano foi internada por 5 dias com 'dor no peito e falta de ar' na segunda semana após artroplastia de joelho, recebendo alta com rivaroxabana por 3 meses. Exame: segunda bulha hiperfonética, sem estertores. Espirometria normal. Ecocardiograma: PSAP estimada de 62 mmHg, ventrículo direito dilatado, FE do ventrículo esquerdo de 65%, sem valvopatia. TC de alta resolução sem doença intersticial. O próximo exame mais adequado é:

A) Angiotomografia de tórax

B) Cintilografia de ventilação e perfusão

C) Cateterismo cardíaco direito

D) Polissonografia

---

46 Homem de 56 anos tem hemocromatose HFE (homozigoto C282Y) diagnosticada há 3 anos com ferritina de 2.400 ng/mL, tratado com flebotomias semanais até ferritina de 50 ng/mL e hoje em manutenção a cada 3 meses. Persiste com dor mecânica e rigidez nas 2ª e 3ª metacarpofalangeanas de ambas as mãos e nos tornozelos, sem sinovite, que atrapalham o trabalho. Exames de hoje: Hb 14,1 g/dL, ferritina 62 ng/mL, saturação de transferrina 38%, cálcio, magnésio e PTH normais. Radiografias: redução do espaço articular com osteófitos em gancho nas 2ª e 3ª metacarpofalangeanas e condrocalcinose nos joelhos. Ele pergunta se aumentar as sangrias melhoraria as articulações. A conduta mais adequada é:

A) Flebotomias semanais até ferritina abaixo de 20

B) Manter a manutenção e tratar a dor

C) Associar deferasirox às flebotomias

D) Iniciar prednisona 10 mg/dia

---

47 Homem de 67 anos tem icterícia indolor e prurido há 3 semanas, perda de 3 kg e diabetes diagnosticado há 2 meses. Afebril. Bilirrubina total 6,2 mg/dL, fosfatase alcalina 540 U/L, GGT 690 U/L, CA 19-9 de 48 U/mL, IgG4 sérica de 540 mg/dL (referência até 135). TC: pâncreas difusamente aumentado, em salsicha, com halo hipodenso periférico, sem massa focal e sem dilatação do ducto pancreático principal; estenose do colédoco intrapancreático; lesões hipodensas corticais bilaterais nos rins. Glândulas submandibulares aumentadas e endurecidas. A conduta mais adequada é:

A) Rituximabe como indução

B) Ecoendoscopia com punção antes do corticoide

C) Duodenopancreatectomia

D) Prednisona 0,6 a 1 mg/kg/dia

---

48 Homem de 38 anos, sem acompanhamento médico, chega com cefaleia e borramento visual há uma semana. PA 236/138 mmHg nos dois braços, FC 92 bpm, sem déficit focal, sem dor torácica. Fundo de olho: hemorragias em chama de vela, exsudatos algodonosos e edema de papila bilateral. Exames: hemoglobina 10,1 g/dL, VCM 92 fL, plaquetas 82.000/mm³, esquizócitos 2% no esfregaço, LDH 780 U/L, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo, INR 1,1, creatinina 4,8 mg/dL (sem exames prévios), ureia 132 mg/dL, potássio 4,6 mEq/L, urina com proteinúria 2+ e 10 hemácias por campo. Foi colhida amostra para atividade de ADAMTS13, com resultado em cinco dias. A conduta inicial mais adequada é:

A) Plasmaférese empírica imediata

B) Eculizumabe empírico imediato

C) Anti-hipertensivo venoso titulável

D) Hemodiálise de urgência

---

49 Homem de 54 anos, transplantado renal há 2 anos, usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 5 mg/dia. Há 3 semanas tem cefaleia progressiva e, há 3 dias, lentificação e confusão leve. Exame: T 37,8 °C, Glasgow 14, sem déficit focal, sem rigidez de nuca. TC de crânio sem lesões. Líquor: pressão de abertura de 32 cmH2O, 40 células/mm³, glicose baixa, tinta da China positiva e antígeno criptocócico de 1:1.024. Creatinina de 1,9 mg/dL (basal 1,5 mg/dL), potássio 4,8 mEq/L. HIV não reagente. Quanto ao antifúngico de indução e ao manejo da imunossupressão, respectivamente:

A) Anfotericina desoxicolato e flucitosina / suspensão total

B) Fluconazol 1.200 mg/dia / sem alteração

C) Anfotericina lipossomal e flucitosina / suspensão total

D) Anfotericina lipossomal e flucitosina / redução gradual

---

50 Homem de 69 anos, com cardiopatia isquêmica e FE de 35%, refere perda de 8 kg em 6 meses, sudorese noturna e saciedade precoce. Baço palpável a 16 cm do rebordo costal. Hb 11,2 g/dL, leucócitos 13.800/mm³ com mielócitos, metamielócitos, 2% de blastos e eritroblastos circulantes, monócitos 600/mm³, plaquetas 190.000/mm³, LDH 780 U/L. Esfregaço com hemácias em lágrima. Aspirado de medula seco; a biópsia mostra fibrose reticulínica grau 3 e megacariócitos atípicos em agrupamentos. JAK2 V617F negativo, mutação de CALR positiva, BCR-ABL1 negativo. Nunca teve eritrocitose nem trombocitose. O diagnóstico e o tratamento inicial são, respectivamente:

A) Mielofibrose primária / ruxolitinibe

B) Mielofibrose primária / transplante alogênico

C) Leucemia mieloide crônica / imatinibe

D) Leucemia de células pilosas / cladribina

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 14

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)		